

Relatórios do Tasy para a CCIH

Lista de extrações, periodicidade e forma de entrega — para a equipe de TI

CCIH / HNSC — setembro de 2026

A CCIH registra e classifica as infecções em sistema próprio; o que precisamos do Tasy são os **relatórios brutos** abaixo, em planilha. A importação deduplica sozinha, então **períodos sobrepostos não são problema** — pode sempre exportar “últimos 30 dias”, por exemplo.

Regras que valem para todos os relatórios

1. **Formato: Excel (xlsx/xls) ou CSV — nunca PDF.** PDF exige reconstrução manual e perde dados.
2. **Toda linha precisa do nº de ATENDIMENTO** (e do prontuário, quando houver). É a chave que liga os relatórios entre si.
3. **Nomes de colunas estáveis:** o sistema da CCIH memoriza o layout de cada relatório; mudar o cabeçalho quebra o reconhecimento automático.
4. **Uma linha por evento** (uma cultura, uma prescrição, uma internação) — sem células mescladas, sem totais no meio.

Os relatórios

#	Relatório	Frequência	Colunas essenciais	Observações
1	Culturas do laboratório	Diário (dias úteis)	ID do exame, atendimento, nome, data coleta, data resultado, setor, material, resultado, microrganismo, antibiograma	Substituir os PDFs diários por planilha. A partir de set/2026 o laudo vem com o nº de atendimento — manter.
2	Pacientes em isolamento (foto do momento)	Diário	Atendimento, nome, setor, leito, data internação, data início do isolamento, precaução, motivo	É a “foto de agora”: cada carga encerra sozinha as precauções de quem saiu da lista.
3	Censo de internações	Diário (mínimo 3×/semana)	Prontuário, atendimento, nome, data de nascimento, telefone, data internação, data alta, desfecho, setor atual, leito, clínica	PEDIDO NOVO: incluir as PASSAGENS DE SETOR (data/hora de cada transferência). Sem isso não há taxa de infecção por unidade.
4	Antibióticos prescritos (ainda não recebemos — é o que falta)	Diário (dias úteis)	Atendimento, antibiótico, dose, via, frequência, data início, data fim/suspensão, setor, indicação, última evolução	Alimenta a avaliação diária de prescrições e o consumo de antimicrobianos.
5	Cirurgias realizadas	Semanal	Atendimento, data, procedimento, cirurgião, potencial de contaminação, ASA, duração, caráter, profilaxia (antibiótico + horário)	PEDIDO NOVO: o potencial de contaminação vem em branco hoje. Com ele, a vigilância pós-alta seleciona as cirurgias limpas sozinha.
6	Dispositivos	Semanal	Atendimento, nome, dispositivo, data	Confere as retiradas

#	Relatório	Frequência	Colunas essenciais	Observações
	invasivos (CVC, VM, SVD...)		instalação, data retirada	combinadas na visita da UTI e os dias de dispositivo.
7	Óbitos	Mensal	Atendimento, nome, data entrada, data óbito, idade, sexo, médico, setor	Uma vez só: exportação retroativa desde 2021, para fechar o desfecho do histórico.
8	Catálogo de antimicrobianos da farmácia	Semestral	Código do material, descrição, subgrupo, classe	Já recebemos um exemplar — atualizar quando mudar a padronização.

Como entregar (sugestão)

O Tasy roda sobre Oracle. A forma mais simples e robusta de atender esta lista é **uma consulta SQL agendada por relatório** (DBMS_SCHEDULER ou script no servidor), gravando o CSV direto numa pasta de rede da CCIH — sem tela, sem relatório formatado, sem ninguém clicando. SELECT com as colunas da lista, uma linha por registro, nome de arquivo com a data. O sistema da CCIH importa a pasta inteira em lote.

Alternativa sem DBA: o agendamento de relatórios do próprio Tasy (geração e envio por e-mail em horário programado) também atende, desde que o layout não seja alterado depois.

Exemplos de layout que já funcionam: a CCIH guarda os arquivos já importados e pode fornecer um exemplar de cada relatório como referência.

O que NÃO precisamos mais

- **Vigispec** — descontinuado. A higiene das mãos passa a ser registrada por aplicativo próprio da CCIH.
- **Relatório de infecções/IRAS de outro sistema** — as infecções são classificadas e registradas dentro do sistema da CCIH, a partir das culturas e da vigilância ativa.

Prioridade, se for preciso escalonar

1. **Antibióticos prescritos** (item 4) — é a única fonte que ainda não existe.
2. **Passagens de setor no censo** (item 3) — destrava as taxas de infecção por unidade.
3. **Potencial de contaminação nas cirurgias** (item 5).
4. **Culturas em planilha diária** no lugar dos PDFs (item 1).

Contato: Dr. Rogério Sobroza — CCIH